ASST Navigli e Ticinello
Ospedale Sant'Eustorgio
SIMT - Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale
Ambulatorio Patient Blood Management (PBM)
Direttore: Dott. Carlo Brivio

Via Conca del Naviglio 22
20123 Milano
Segreteria 02 58391402
Urgenze trasfusionali h24 02 58391499
simt.pbm@asst-navigliticinello.example.it

REFERTO IMMUNOEMATOLOGICO E VALUTAZIONE PBM

Percorso pre-operatorio per chirurgia ortopedica maggiore in paziente che rifiuta la trasfusione

ALLERTA TRASFUSIONALE - La paziente, Testimone di Geova, rifiuta sangue intero, emazie, plasma e piastrine anche in caso di pericolo di vita (DAT depositata presso il Comune di Milano). Accetta recupero intraoperatorio di sangue in circuito continuo, albumina e fattori della coagulazione ricombinanti.

DATI DEL PAZIENTE

Cognome:	**DELL'ORTO**
Nome:	**ROSA**
Nata il:	**25/01/1948 (78 anni)**
Sesso:	**F**
Residenza:	**Via Giambellino 74, 20146 Milano**
Stato civile:	**vedova**
Invalidita':	**invalidita' civile 75%**
Amm. di sostegno:	**Ettore Brambilla (decreto R.G. 4471/2024)**
Familiare:	**figlia Bianca Colombo, tel. +39 333 609 1187**

N. accettazione:	IE-26-022514
Richiedente:	Dott. Luca Vergani
Reparto:	UOC Ortopedia e Traumatologia
Intervento:	artroprotesi totale d'anca destra
Ricovero previsto:	09/11/2026
Prelievo:	01/10/2026 ore 10:15
Referto:	03/10/2026

Provetta tappo rosa (K2-EDTA):
IE26022514R

Codice fiscale D L L R S O 4 8 A 6 5 F 2 0 5 V

Tessera sanitaria 8 0 3 8 0 0 3 0 8 2 0 7 4 3 2 9 0 4 2 5

IMMUNOEMATOLOGIA

Esame	Risultato	Metodo	Note
Gruppo AB0 e Rh(D)	A Rh(D) negativo	Gel test, doppia determinazione	Concorde con storico del 12.05.11
Fenotipo Rh	ccddee (rr)	Gel test	-
Antigene Kell	K negativo	Gel test	-
Fenotipo esteso	Fy(a+b-), Jk(a-b+)	Gel test	Sistemi Duffy e Kidd
Coombs indiretto (TAI)	Positivo	Gel test LISS	Alloimmunizzazione verosimilmente da 3 pregresse gravidanze
Identificazione anticorpi	anti-E + anti-Jka	Pannello 11 cellule	Titolo anti-E 1:16; anti-Jka debole (1)
Coombs diretto (TAD)	Non agglutinante	Gel test polispecifico	-

EMATOLOGIA E ASSETTO MARZIALE

Esame	Risultato	U.M.	Valori di riferimento	
Emoglobina	10,2	g/dL	12,0 - 15,5	L
MCV	79,6	fL	80,0 - 99,0	L
Reticolociti	1,1	%	0,5 - 2,0	
Ferritina	16	ng/mL	30 - 300 (PBM)	L
Saturazione transferrina	7	%	20 - 45	L
Folati sierici	2,9	ng/mL	3,9 - 26,8	L
Vitamina B12	412	pg/mL	197 - 771	
Creatinina	0,98	mg/dL	0,50 - 0,90	H
eGFR (CKD-EPI)	57	mL/min	> 60	L
Proteina C reattiva	0,42	mg/dL	< 0,50	

COAGULAZIONE

Esame	Risultato	U.M.	Valori di riferimento	
PT - INR	1,04		0,80 - 1,20	
aPTT ratio	0,97		0,82 - 1,18	

Esame	Risultato	U.M.	Valori di riferimento	
Fibrinogeno	356	mg/dL	200 - 400	
Piastrine	241	10^3/µL	150 - 400	

COLLOQUIO E VALUTAZIONE CLINICA

Colloquio del 1 ottobre 2026 con la sig.ra Dell'Orto, alla presenza della figlia Bianca e dell'amministratore di sostegno, sig. E. Brambilla. La paziente, affetta da decadimento cognitivo lieve e da sindrome depressiva in terapia con sertralina 50 mg, appare orientata e in grado di esprimere una volonta' coerente con la DAT del 2019: conferma il rifiuto di emocomponenti per motivi religiosi. Anamnesi: coxartrosi destra, ipertensione arteriosa in terapia con ramipril 5 mg, allergia a penicillina (orticaria). Valutazione anestesiologica congiunta con il Dott. Federico Mapelli: rischio emorragico stimato elevato in presenza di alloanticorpi multipli, che renderebbero comunque difficoltoso il reperimento di unita' compatibili. La paziente R. Dell'Orto e la figlia sono state informate dei rischi; l'AdS ha preso atto delle volonta' espresse.

PIANO PBM CONCORDATO

Data	Azione	Farmaco / procedura	Esecuzione / note
06/10/2026	Correzione carenza marziale	carbossimaltosio ferrico 1000 mg e.v.	Somministrato in day hospital dall'inf. Giada Sironi
13.10.26	Stimolazione eritropoietica	epoetina alfa 40.000 UI s.c.	Settimanale per 3 dosi; controllo PA a cura dell'inf. G. Sironi
13.10.26	Supplementazione	acido folico 5 mg die	Fino all'intervento
2 novembre 2026	Controllo pre-ricovero	Emocromo, reticolociti, ferritina	Obiettivo: Hb pre-operatoria pari o superiore a 13 g/dL
Intra-operatorio	Risparmio ematico	acido tranexamico 1 g e.v. recupero intraoperatorio di sangue in circuito continuo	Concordato con l'anestesista, Dott. F. Mapelli, e con l'operatore, Dott. L. Vergani

Volonta' espresse dalla paziente (DAT confermata)

- ☒ Rifiuta emazie concentrate e sangue intero
- ☒ Rifiuta plasma e piastrine
- ☒ Accetta albumina e fattori ricombinanti
- ☒ Accetta recupero intraoperatorio in circuito continuo
- ☐ Accetta emodiluizione normovolemica

Firma della paziente: Rosa Dell'Orto
Firma dell'AdS: Ettore Brambilla
Testimone: inf. Nicolo' Fumagalli
Milano, 01/10/2026

SIMT - OSPEDALE SANT'EUSTORGIO
Dott.ssa Paola Galbiati
Dirigente Medico
Ord. Medici MI n. 39027

Il Dirigente Medico SIMT
Dott.ssa Paola Galbiati
Visto: Dott. Carlo Brivio, Direttore SIMT

Milano, 3 ottobre 2026

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Scheda PBM di Dell'Orto Rosa - consultazione per il reparto:
https://pbm.asst-navigliticinello.example.it/s/SIMT-26-0039914

(1) Anti-Jka del sistema Kidd: anticorpo a titolo debole, a rischio di reazione emolitica ritardata; comunicato al Dott. L. Vergani il 03/10/2026.
(2) La figlia, sig.ra B. Colombo, ha chiesto di essere contattata al +39 333 609 1187 per ogni variazione del piano.
(3) Provetta tappo rosa (K2-EDTA) per immunoematologia: validita' del campione 72 ore dal prelievo.